

Integraal Klinisch Intake- en Interviewprotocol voor Kinderen

Gestructureerd intake- en interviewprotocol vanaf de eerste ontmoeting in de speelkamer

Een methodische leidraad voor kindertherapeuten en jeugdprofessionals bij het voeren van diagnostische kindgesprekken en intake-interviews. Dit protocol biedt een duidelijke fasering van eerste verwelkoming tot afronding, inclusief woordelijke voorbeeldvragen, praktische tips voor lastige gesprekssituaties, een systematische observatiechecklist en een geanonimiseerde casus.

-
- | | |
|---|---|
| 01 Methodisch Kader en Doelstelling | 02 Procesarchitectuur van het Kindinterview |
| 03 Klinische Beslisboom: Gespreks- of Spelmodus | 04 Fase 1: Kennismaking en Veiligheid (10-15 min) |
| 05 Fase 2: Neutrale Exploratie van de Leefwereld (10-15 min) | 06 Fase 3: Verdieping naar Zorgen en Belevingswereld (15-20 min) |
| 07 Fase 4: Spel- en Interactie-observatie (15-20 min) | 08 Fase 5: Afronding en De-escalatie (5-10 min) |
| 09 Systematische Gedrags- en Spelobservatie Checklist | 10 Praktijkvoorbeeld: Geanonimiseerde Casus 'Milan' (8 jaar) |
| 11 Quick-Reference Spiekkaart voor de Behandelkamer | |

Methodisch Kader en Doelstelling

Dit interviewprotocol is ontwikkeld als houvast voor diagnostici en behandelaren tijdens de verkennende fase met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het doel van het kindinterview is niet om een verhoor af te nemen, maar om een veilige werkrelatie op te bouwen, inzicht te krijgen in de subjectieve belevingswereld van het kind en samen te onderzoeken wat er goed gaat en wat als lastig wordt ervaren. De opbouw volgt vijf fasen die naadloos kunnen overvloeien tussen verbale uitwisseling en spelobservatie.

- Transparantie en voorspelbaarheid: leg het kind direct uit wat het doel is en wie er toegang heeft tot de besproken informatie.
- Aansluiting bij ontwikkelingsniveau: wissel taal af met concrete materialen, tekenen en spelvormen.
- Veiligheid voorop: forceer geen antwoorden wanneer sprake is van schroom, angst of loyaliteitsconflicten.
- Evenwicht tussen klachten en krachten: breng naast zorgen ook competenties en beschermende factoren in kaart.

Kadering van Vertrouwelijkheid

Leg vertrouwelijkheid altijd uit in kindertaal: 'Alles wat we hier bespreken blijft tussen ons, behalve als er dingen gebeuren die onveilig zijn voor jou of iemand anders. Als ik iets aan je ouders vertel, overleggen we dat altijd eerst samen.'

Procesarchitectuur van het Kindinterview

Het kindgesprek verloopt langs vijf methodische stappen. De overgang tussen de stappen gebeurt op basis van de emotionele draagkracht en bereidheid van het kind.



- Fase 1: Kennismaking en installeren van veiligheid (10-15 minuten)
- Fase 2: Neutrale exploratie van leefwereld en interesses (10-15 minuten)
- Fase 3: Verdieping naar zorgen, krachten en doelen (15-20 minuten)
- Fase 4: Spel- en interactie-observatie (15-20 minuten)
- Fase 5: Synthese, afronding en ontspanning (5-10 minuten)

🎯 Klinische Beslisboom: Gespreks- of Spelmodus

Niet ieder kind kan of wil direct verbaal reflecteren. Gebruik onderstaande afweging om te bepalen wanneer je overschakelt van een zittend vraaggesprek naar een doe- of spelvorm.



Hoe reageert het kind op de eerste open verkennende gespreksvragen?



Kind praat ontspannen, maakt oogcontact en vertelt spontaan verhalen

Vervolg het gesprek stapsgewijs langs de fasen. Bied optioneel tekenpapier of klei aan als neutrale bezigheid tijdens het praten.



Kind geeft enkel 'ja', 'nee' of 'weet ik niet', kijkt weg of verstijft

Stop direct met directe vragen. Schakel over naar de zandtafel, duplo of het kiezen van gevoelskaarten. Verwoord het proces: 'Praten is soms best stom als je iemand nog niet kent. Zullen we eerst kijken wat hier staat?'



Kind toont hevige motorische onrust of ontregeling bij probleemonderwerpen

Bied een sensomotorische activiteit aan (zoals kinetisch zand of een bal overgooien) om arousal te reguleren voordat er opnieuw betekenis wordt gegeven aan het thema.

- Let op signalen van motorische onrust, verstarring of vermijdend antwoordgedrag.
- Pas het medium aan aan de regulatietoestand van het kind, niet andersom.



Fase 1: Kennismaking en Veiligheid (10-15 min)

In deze fase wordt het fundament gelegd voor de werkrelatie. We nemen spanning weg door helderheid te verschaffen over wie de therapeut is, wat de speelkamer is en dat het kind niet beoordeeld of getoetst wordt.

- Doelstelling: Verlaging van anticipatieangst, vestigen van veiligheid en wederzijdse verwachtingen.
- Voorbeeldvraag 1: 'Wist je al een beetje wat we hier vandaag gingen doen, of was het nog een verrassing?'
- Voorbeeldvraag 2: 'Je mag eerst eens rustig rondkijken in de kamer. Wat valt jou als allereerste op hier?'
- Voorbeeldvraag 3: 'Als we hier samen zijn, mag jij bepalen waar we het over hebben en wat we doen. Is er iets wat ik moet weten om het voor jou fijn te maken?'

Wat als het kind weigert de wachtkamer te verlaten?

Dwing het kind niet los van de ouder. Nodig ouder en kind samen uit in de behandelkamer voor de eerste 10 minuten. Laat de ouder op een neutrale stoel zitten terwijl jij het kind de ruimte laat verkennen. Zodra het kind ontspant, vraag je: 'Vind je het goed als mama/papa even een kop thee drinkt in de gang, of wil je dat ze er nog even bij blijven?'



Fase 2: Neutrale Exploratie van de Leefwereld (10-15 min)

Voordat problemen aan bod komen, onderzoeken we de vertrouwde context van het kind. Dit biedt inzicht in interesses, sociale steunbronnen en executieve communicatievaardigheden in een onbeladen context.

- Doelstelling: Bepalen van de communicatieve baseline en identificeren van hulpbronnen en competenties.
- Voorbeeldvraag 1: 'Als jij op een vrije woensdagmiddag helemaal zelf mag kiezen wat je doet, hoe ziet die dag er dan uit?'
- Voorbeeldvraag 2: 'Wie op school of thuis laat jou het hardste lachen, en wat doen jullie dan samen?'
- Voorbeeldvraag 3: 'Waar ben jij echt supergoed in, of waar ben je de laatste tijd heel trots op geweest?'

Wat als het kind antwoordt met 'niks is leuk' of apathie toont?

Sluit aan bij de beleving in plaats van te corrigeren: 'Het klinkt alsof je er vandaag helemaal geen zin in hebt of dat alles even saai voelt. Dat mag ook. We hoeven niet te doen alsof alles fantastisch is.' Schakel over naar nieuwsgierigheid naar wat stom is: 'Wat is op dit moment het meest irritante ding van de week?'



Fase 3: Verdieping naar Zorgen en Belevingswereld (15-20 min)

In deze fase richten we ons op de zorgen die door ouders, school of het kind zelf zijn gesignaleerd. We onderzoeken hoe het kind zijn eigen situatie ervaart zonder schuld of loyaliteitsdruk op te leggen.

- Doelstelling: Zicht krijgen op de beleving van klachten, interne verklaringsmodellen en de wens tot verandering.
- Voorbeeldvraag 1: 'Grote mensen praten vaak over kinderen als er zorgen zijn. Wat denk jij dat papa en mama tegen mij hebben verteld over waarom je hier bent?'
- Voorbeeldvraag 2: 'Als je een toverstaf had en je mocht één ding veranderen aan hoe jij je vanbinnen voelt, wat zou je dan wegtoveren?'
- Voorbeeldvraag 3: 'Stel dat jouw boosheid (of verdriet) een monster of diertje was: hoe groot is het dan nu, en waar in je lijf zit het verstopt?'

Wat als het kind zegt: 'Er is helemaal niks met mij aan de hand'?

Erken de positie van het kind en verplaats de druk: 'Dat snap ik heel goed. Soms maken volwassenen zich veel te veel zorgen om dingen waar jij helemaal geen last van hebt. Vertel eens: wat maken zij volgens jou groter dan het eigenlijk is?'



Fase 4: Spel- en Interactie-observatie (15-20 min)

Spel is de natuurlijke taal van het kind. Tijdens het spel observeren we interactiepatronen, vermogen tot fantasiespel, omgang met regels en emotionele thema's die niet rechtstreeks met woorden kunnen worden uitgedrukt.

- Doelstelling: Diagnostische observatie van zelfregulatie, thematiek, rolpatronen en creativiteit.
- Voorbeeldvraag 1: 'Kijk eens tussen deze spullen: als we een verhaal zouden bouwen, wie zijn dan de hoofdrolspelers?'
- Voorbeeldvraag 2: 'Welke rol moet ik spelen van jou: ben ik de bewaker, de helper of iemand anders?'
- Voorbeeldvraag 3: 'Wat gebeurt er als de vulkaan of de storm plotseling uitbarst in dit kasteel?'

Wat als het kind agressief of grensoverschrijdend materiaal gebruikt?

Begrens rustig en empathisch: 'Ik zie dat de draak heel boos is en alles kapot wil gooien. In deze kamer houden we alle spullen en elkaar heel. De draak mag wel op het bokskussen slaan of in de klei stampen, maar niet met de houten blokken gooien.'

✓ Fase 5: Afronding en De-escalatie (5-10 min)

Een zorgvuldige afronding zorgt ervoor dat het kind emotioneel gereguleerd en met een positief gevoel de sessie verlaat. We borgen het gevoel van eigenaarschap en bespreken wat er gedeeld wordt met de ouders.

- Doelstelling: Emotionele stabilisatie, herstel van evenwicht en afstemmen van de terugkoppeling naar ouders.
- Voorbeeldvraag 1: 'We hebben nog 5 minuten. Zullen we samen kijken welk speelgoed weer terug op zijn vaste plekje mag?'
- Voorbeeldvraag 2: 'Wat vond je vandaag het fijnste om te doen, en wat vond je misschien een beetje gek of lastig?'
- Voorbeeldvraag 3: 'Straks zien we je ouders weer. Is er iets wat jij wilt dat ik zéker aan hen vertel, of juist iets wat je liever even geheimhoudt?'

Wat als het kind ontregeld raakt omdat de tijd voorbij is?

Kondig de afronding altijd visueel en tijdig aan (bijvoorbeeld met een zandloper of timer van 5 minuten). Als het kind niet wil stoppen: 'Ik zie hoeveel plezier je had in dit bouwwerk. Laten we er een foto van maken of een bordje 'Niet aankomen' bij zetten, zodat we er de volgende keer meteen mee verder kunnen.'

☒ Systematische Gedrags- en Spelobservatie Checklist

Gebruik onderstaande afvinklijst tijdens of direct na afloop van de interviewsessie om systematische observaties vast te leggen over de belangrijkste diagnostische domeinen.

- ☐ Uiterlijke verzorging, motoriek en houding: ontspannen, gespannen, verkrampd, rusteloos of geremd gedrag.
- ☐ Contactgroei en oogcontact: passend oogcontact, vermijdend, overmatig aanklampend of wisselend.
- ☐ Spraak en taalgebruik: articulatie, woordenschat, spreek snelheid, volume en samenhang van het narratief.
- ☐ Affect en stemming: congruent met gespreksonderwerp, vlak, labiel, angstig, prikkelbaar of opgewekt.
- ☐ Spelgedrag en thematiek: verkennend, constructief, thematisch (macht, controle, zorg, verlating), chaotisch of rigide.
- ☐ Frustratietolerantie: reactie op grenzen, regels of mislukkingen tijdens spel- of tekenopdrachten.

Geobserveerd contactgedrag & affectregulatie:

Spelthema's, metaforen & gehanteerd materiaal:

Opvallende sterke kanten & beschermende factoren:



Praktijkvoorbeeld: Geanonimiseerde Casus 'Milan' (8 jaar)

Aanmelding: Milan is door school en ouders aangemeld vanwege plotselinge boosheidsbuien in de klas en moeite met inslapen sinds de echtscheiding van zijn ouders een half jaar geleden. Hieronder volgt een geannoteerd fragment uit het intake-interview.

- Therapeut: 'Milan, als jij thuis boos wordt, hoe ziet dat er dan uit voor iemand die naar je kijkt?'
- Milan: (Kijkt naar de vloer, friemelt aan zijn trui) 'Gewoon stom. Iedereen zeurt altijd over mijn kamer.'
- Therapeut (Interventie - validatie en de-escalatie): 'Het is ook heel vermoeiend als iedereen steeds op je let. Zullen we het niet over die kamer hebben, maar eens kijken naar deze doos met dierenfiguren? Welk dier heeft volgens jou de allersterkste boosheid in zich?'
- Milan (Kiest een gorilla): 'Deze. Hij slaat alles kapot als ze hem opsluiten in de kooi.'
- Therapeut: 'Een gorilla in een kooi. En wat heeft die gorilla eigenlijk het allermeeeste nodig om weer rustig adem te kunnen halen?'
- Milan: 'Dat de deuren open mogen en dat hij niet steeds hoeft te kiezen wie hij moet beschermen.'
(Kern van loyaliteitsconflict zichtbaar gemaakt via metafoor).

Klinische Reflectie bij de Casus

Door direct af te stappen van de rationele 'waarom-vraag' en over te schakelen naar de diermetafoor, verdween Milans defensieve houding. Binnen drie minuten werd de dieper liggende emotionele dynamiek (gevoel van klem zitten tussen ouders) helder zonder dat Milan het gevoel kreeg zijn ouders af te vallen.

☒ Quick-Reference Spiekkaart voor de Behandelkamer

Houd dit beknopte overzicht binnen handbereik tijdens de intake om het overzicht over de fasen en kernvragen te bewaren.

- ☐ 1. KENNISMAKING: 'Wat fijn dat je er bent. Weet je al wat we gaan doen, of was het een verrassing?'
- ☐ 2. EXPLORATIE: 'Als jij de baas bent over een hele vrije dag, hoe ziet die er dan uit?'
- ☐ 3. VERDIEPING: 'Wat denken papa en mama dat hier het lastigste voor jou is, en wat vind jij zelf?'
- ☐ 4. OBSERVATIE: 'Welk verhaal gaan we bouwen, en wie speel ik in jouw spel?'
- ☐ 5. AFRONDING: 'Wat vond je het leukst vandaag, en wat mogen we al aan papa en mama vertellen?'

Persoonlijke aantekeningen & follow-up afspraken:
